

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5107293-32.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: MARIA LUCINDA ARAUJO LIMA

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARICA

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

AGRAVO/MEDIDA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. SARCOIDOSE. MEDICAMENTO INFliximABE 5MG/KG. DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA. ARTIGO 196 E 198 DA CRFB/88 E JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Intimem-se e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5107293-32.2024.4.02.5101

510015403251 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5107293-32.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: MARIA LUCINDA ARAUJO LIMA

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARICA

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo/medida de urgência interposta pela parte autora a fim de obter medicamento Infliximabe 5mg/kg, conforme prescrito para terapia em casos recidivantes, por tempo de uso indeterminado.

Alega a urgente e necessária medida antecipatória, uma vez que depende do referido fármaco para manter sua saúde de forma ininterrupta. Narra ser portadora de Sarcoidose (CID 10 D 86.2), desde 2019, com quadro de linfonodomegalia, nódulos pulmonares, febres, artralgia e lesões cutâneas.

Sem contrarrazões.

Pedido liminar indeferido no evento 3.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Inicialmente, a preservação da saúde é dever genérico solidário de todas as entidades federativas (art. 23, II e 196, CF/88). No entanto, as atribuições públicas específicas no campo da saúde, são descentralizadas, sendo a responsabilidade limitada à própria esfera de atribuições definidas em lei, conforme dispõem os art. 197 e 200 CF/88.

Nesse particular, descentralização, hierarquização e regionalização dos serviços de saúde são diretrizes básicas e princípios constitucionais do Sistema Único de Saúde – SUS, “sic”:

Art. 198 As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo.” (grifo nosso)

Regulamentando essa disposição constitucional e com ênfase especial à descentralização dos serviços, preceito inserido no art. 198, I CF/88, foram editadas as Leis nº 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde) e 8.142/90 (financiamento do SUS), além de inúmeras outras normas infraconstitucionais.

Nesse particular, é clara a Lei 8.080/90 quando determina a descentralização de medidas com ênfase para os municípios, conforme:

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

(...)

IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo:

a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;

b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde;

(...)

Destarte, fica evidente que as responsabilidades quanto à execução das ações finalísticas de prestação de serviços de saúde, dividem-se entre a União, os Estados e os Municípios, cada um dentro de suas respectivas esferas de atribuição, devendo-se ressaltar aqui, que à União compete basicamente a formulação de políticas nacionais, financiamento do Sistema, com o repasse de verbas próprias a Estados e Municípios, sendo que a estes últimos ficaria a principal atribuição de prestar o atendimento ao cidadão, especialmente no campo do fornecimento de medicamentos.

Vejamos agora questões específicas que se apresentam regularmente nesta Justiça Federal.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE SAÚDE

As atribuições relativas à assistência farmacêutica no campo da saúde pública, englobam as *atividades de seleção, programação, aquisição, armazenamento e distribuição, controle da qualidade e utilização - compreendidas a prescrição e a dispensação - de medicamentos* (artigos 16, X; 17, VIII; e 18, V, da Lei n. 8.080/1990 e item 3.3 da Portaria MS n. 3.916, de 30 de outubro de 1998 - Política Nacional de Medicamentos). O Decreto nº 7.508/11 recentemente deu nova regulamentação à Lei 8.080/80, não alterando a linha da descentralização.

Em toda hierarquização e descentralização quanto ao fornecimento direto de medicamentos e demais insumos respectivos, fica claro que: (i) cabem ao gestor municipal as responsabilidades para definição dos medicamentos essenciais e para o seu abastecimento. Ou seja, os medicamentos fornecidos pelo município são aqueles considerados básicos e indispensáveis para atender a maioria dos problemas de saúde da população; (ii) compete aos Estados federados a dispensação de medicamentos de ordem excepcional, ou seja, medicamentos utilizados em doenças raras, geralmente de custo elevado, cuja compra e disponibilização atende a casos específicos; (iii) por fim, quanto à União Federal, é conferida pela Política Nacional de Medicamentos a responsabilidade em adquirir e distribuir produtos em situações especiais considerando três pressupostos básicos, de ordem epidemiológica, a saber: a) doenças que configuram problemas de saúde pública, que atingem ou põem em risco a coletividade, e cuja estratégia de controle concentra-se no tratamento de seus portadores; b) doenças consideradas de caráter individual que, a despeito de atingir número reduzido de pessoas, requerem tratamento longo ou até permanente, com o uso de medicamentos de custos elevados; c) doenças cujo tratamento envolve o uso de medicamentos não disponíveis no mercado.

Portanto, a conclusão a que se chega é que a competência da União no fornecimento de medicamentos, conforme farta regulamentação, se refere aos: a) medicamentos de interesse em saúde pública: aqueles utilizados no controle de doenças que, em determinada comunidade, têm magnitude, transcendência ou vulnerabilidade relevante e cuja estratégia básica de combate é o tratamento dos doentes; e b) medicamentos de uso contínuo: são aqueles empregados no tratamento de doenças crônicas e ou degenerativas, utilizados continuamente, sendo que em ambos os casos, só serão fornecidos pela União aqueles que se encaixarem no perfil estratégico concernente à definição de sua esfera de responsabilidade.

Com base nessa divisão de responsabilidades, delimita-se a competência da Justiça Federal e consequentemente dos Juizados Especiais Federais para apreciar as ações que objetivam o fornecimento de medicamentos, atendo-se somente àquelas em que a dispensação de medicamentos caiba à União Federal.

Na mesma linha da argumentação acima, segue parte da jurisprudência do STJ e também a jurisprudência pacífica do TRF da 2ª Região, conforme, com grifos nossos:

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. EXECUÇÃO DIRETA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO FEDERAL.

I - A Primeira Turma deste Superior Tribunal de Justiça vem decidindo pela ilegitimidade da União para figurar em ação para fornecimento gratuito de medicamentos.

II - A competência da União está adstrita à gestão federal do SUS, repassando os recursos financeiros, cabendo então aos Municípios e, supletivamente, aos Estados, a aquisição e a adequada dispensação de medicamentos. Precedente: (AgRg no REsp nº 888.975/RS, Relator p/ Acórdão Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 22.10.2007).

III - Agravo regimental provido. (STJ - AgRg no Ag 879.975/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, Rel. p/ Acórdão Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJe 14/04/2008)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. UNIÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A sentença, também condicionada a reexame necessário, ratificando a decisão antecipatória, condenou somente a União a fornecer ao autor, portador de esquizofrenia psicótica, os medicamentos Losartana Potássica 100mg/dia; Pimozida 04 mg/dia; Flurazepan 30 mg/dia, e Dicloridrato de Manidipin, disponibilizando quantidade suficiente para o tratamento no período de 180 (cento e oitenta) dias, de acordo com a necessidade diária prescrita nos laudos médicos..., nas quantidades mensais especificadas com base nos receituários..., devendo o Autor apresentar, a cada 06 (seis) meses, receituário atualizado, comprovando a necessidade de uso continuado dos referidos medicamentos. 2. A União Federal, em regra, no âmbito do SUS, não tem atribuição de distribuir diretamente medicamentos, do que decorre a sua ilegitimidade passiva para responder ações movidas para obtê-los. Inteligência da Lei nº 8.080/90. Precedentes da Turma. 3. A remessa dos autos à Justiça Estadual, melhor ajustada à sistemática do SUS, tem o efeito prático de aproximar os pacientes necessitados de assistência médico-farmacêutica dos organismos locais responsáveis, assim otimizando a efetividade das prestações demandadas. 4. Na hipótese, a parte autora, portadora de esquizofrenia psicótica, necessita de remédios não integrantes da lista de medicamentos excepcionalmente fornecidos pela União Federal, e dos autos não consta laudo médico categórico afirmativo da essencialidade dos medicamentos em causa, destacando-os como únicos e insubstituíveis para restabelecer a saúde do paciente, e situando-o, nessa medida, em quadro excepcional para justificar tratamento diferenciado, de sorte que se impõe a remessa do feito ao Estado. 5. Apelação da União Federal e Remessa Necessária providas. Apelação da parte autora e agravo retido prejudicados.”

(TRF2, APELRE 200951010132455, Desembargadora Federal NIZETE LOBATO CARMO, SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R 22/01/2013.)

AGRAVOS INTERNOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. EXCLUSÃO DA UNIÃO DO PÓLO PASSIVO. 1. Agravos internos contra a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento e determinou a exclusão da União do pólo passivo da demanda na qual se pede a entrega de medicamentos, com a remessa dos autos ao Juízo estadual competente. 2. A asseveração de solidariedade apenas significa que os entes federativos dos três níveis têm o dever de compor o sistema de saúde pública, na forma delineada pela Constituição Federal e especificada pela legislação infraconstitucional. Assim, ela é insuficiente para fazer com que se possa litigar ou não contra a União Federal, em casos nos quais não existe, na distribuição interna das competências, dever da União de comprar ou fornecer o remédio específico. 3. Agravos internos não providos.” (TRF2, AG 201202010183666, Desembargador Federal GUILHERME COUTO, SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R 17/12/2012.)

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO FEDERAL. REMESSA À JUSTIÇA DO ESTADO.

Em regra, não é pertinente a inserção da UNIÃO FEDERAL no pólo passivo de pleito em que se objetiva obter remédios. A atuação da União Federal, no âmbito do problema relativo a medicamentos, não é a de comprá-los e de distribuí-los, diretamente. O Sistema Único de Saúde objetiva coordenar os recursos e práticas ligadas à saúde pública, de modo a dividir atribuições e obter eficiência. Não cabe à União a compra e a entrega direta de medicamentos, salvo os casos especiais previstos na divisão de atribuições. Assim, exclui-se da lide a União Federal e, com fulcro no artigo 113 do CPC, pronuncia-se a nulidade da sentença, determinada a remessa dos autos à Justiça do Estado, para que lá tudo seja apreciado. Remessa (conhecida de ofício) e apelação da UNIÃO FEDERAL providas. Prejudicado o apelo do Estado do Rio de Janeiro.(TRF2 - AG 201202010107937, Rel. p/acórdão GUILHERME COUTO, E-DJF2R - Data::26/09/2012.)

PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1. Conquanto a apreciação do agravo retido interposto pela União não tenha sido requerida em sua apelação (art. 523, § 1º, do CPC), o recurso poderia ser conhecido por força da remessa necessária. Todavia, não o será porquanto se insurge contra o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela e porque a ilegitimidade passiva suscitada é reiterada nas razões de apelação.

2. A aquisição e distribuição dos medicamentos para combater a doença que acomete a autora (glaucoma) inserem-se entre as atribuições do Estado e do Município (art. 9º, §1º, inciso II, da Portaria nº 288/ SAS, de 19 de maio de 2008). Desprezar a repartição de atribuições, prevista na Lei nº 8.080/90 (artigos 16 a 19) e demais normas que regulamentam o funcionamento do SUS, torna o sistema ineficiente e dispendioso, notadamente em vista de condenações solidárias dos entes ao fornecimento dos mais variados medicamentos. A União não tem a incumbência de adquiri-los e distribuí-los, pois os medicamentos pleiteados não estão listados na Portaria nº 2.981/2009. Reconhecida a ilegitimidade da União e, portanto, a incompetência da Justiça Federal, deve ser declarada a nulidade da sentença e encaminhado o processo à Justiça Estadual (art. 113, § 2º, do CPC).

3. Agravo retido da União não conhecido e remessa e apelação da União providas. Prejudicados os recursos dos demais réus. (grifou-se e destacou-se).

(TRF2, AC 200851010252432, Desembargador Federal LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO, SÉTIMA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R 08/03/2013)

Superada estas questões, verifico que, mediante análise meramente perfunctória, não encontro na exposição da lide a presença dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada requerida.

No caso dos autos, não restou esclarecido, em sede de liminar, de que o remédio requerido é o efetivamente indicado para o tratamento da parte autora, além disso, se realmente é autorizado e não prejudicial, visto que não há liberação pela ANVISA.

Conforme parecer do NatJus (EVENTO 12): "a) o medicamento INFLIXIMABE não apresenta indicação descrita em bula1 , para o tratamento de sarcoidose, quadro clínico apresentado pela Autora, conforme relatado em documento médico. Assim, sua indicação, nesse caso, configura uso *off label*; b) não há autorização excepcional pela ANVISA para o uso off label do medicamento Infiximabe no tratamento sarcoidose; **c) não apresenta autorização para uso off label pelo órgão responsável, na forma da Lei nº 14.313, de 21 de março de 2022**, a qual exige a recomendação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias - CONITEC; d) informa que, de acordo com literatura consultada, na última década, somente 14 ensaios randomizados e controlados (alguns estudos não cegos) foram publicados e indexados no PubMed; porém, o medicamento de escolha ainda é o corticosteroide. e) o Ministério da Saúde ainda não publicou Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas que verse sobre a sarcoidose - quadro clínico apresentado pela Autora e, portanto, não há lista oficial e específica de medicamentos que possam ser implementados nestas circunstâncias; f) O medicamento Infiximabe possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); g) no que tange à disponibilização pelo SUS do medicamento pleiteado, insta informar que Infiximabe 10mg/mL é disponibilizado pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ), através do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF6), aos pacientes que se enquadrem nos critérios de inclusão dos PCDT da Doença de Crohn, Artrite Reumatoide, Artrite Idiopática Juvenil, Artrite Psoriásica, Espondilite Ancilosante e da Retocolite Ulcerativa; destaca-se que a doença do Demandante a saber, D86.2 - Sarcoidose do pulmão com sarcoidose dos gânglios linfáticos, não está dentre as contempladas para a retirada do medicamento através do CEAF, impossibilitando a obtenção do Infiximabe 10mg/mL pela via administrativa. "

Nesse contexto, analisando o presente caso não vislumbro qualquer possibilidade de dano irreparável à recorrente, com consequências letais à sua vida, caso não utilize o medicamento pleiteado no presente momento, mesmo porque, ao menos no presente momento, entendendo ser temerária sua ministração, devendo, de fato, ser o feito melhor instruído neste sentido.

Por outro lado, as razões recursais apenas atacam o provimento indeferitório da tutela antecipada, sem demonstrar fatos hábeis que pudessem evidenciar a verossimilhança das alegações autorais, uma vez que, em ações como a presente, é necessário comprovar a impossibilidade de substituição de remédio fora da lista do SUS.

Portanto, vislumbro não preenchidos os pressupostos autorizadores da antecipação de tutela previstos no artigo 300 do CPC e entendo que os argumentos da parte autora não são suficientes a gerar a revisão de plano da referida decisão.

Ante o exposto, voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Intimem-se e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem. É como voto.